

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro:  
Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:  
turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI**  
**(TURMA) Nº 5017999-45.2018.4.04.7001/PR**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

**REQUERENTE:** EDGAR ALBANO JUNIOR

**REQUERIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**RELATÓRIO**

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 14, §2º, da Lei 10.259/01, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal do Paraná, que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedente o restabelecimento de aposentadoria por invalidez.

Nas razões de recurso, a parte recorrente alega que a decisão impugnada diverge de entendimento firmado pela 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (processos 5017172-65.2018.4.02.5101, 5007322-84.2018.4.02.5101, 5043366-68.2019.4.02.5101) e também pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina (processo 5001474-18.2019.4.04.7206), no sentido de que a regra disposta no art. 43 § 5º da Lei 8.213/91, a qual dispõe que a pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação pericial administrativa, é válida também para as aposentadorias revistas e suspensas pelo INSS antes da promulgação da Lei 13.847, de 19/06/19. Aduz, ainda, que a legislação mais benéfica deve ser aplicada retroativamente.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

Inadmitido o incidente na origem, seguiu-se a interposição de agravo, provido pelo presidente desta TNU.

Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação.

**VOTO**

**Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.**

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente reside no pedido de uniformização sobre a possibilidade, ou não, de retroagir a regra contida no art. 43 § 5º da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 13.847/19, para os benefícios que foram revisados antes de sua edição.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado manteve, por seus próprios fundamentos, sentença que decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo:

*A parte autora ajuizou a presente ação pretendendo o **restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez**, cessado em revisão administrativa em 18/09/2018 (DIB 14/05/2014 e DCB prevista para 18/03/2020).*

*O INSS contestou requerendo a improcedência dos pedidos, arguindo que **no caso em apreço, a perícia médica judicial atestou a total capacidade laborativa da parte autora** (evento 22).*

*Dispensado o relatório nos termos do art. 489, I, do CPC, conforme o permissivo do art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001, passo a decidir.*

### **MÉRITO**

*É sabido que, para a obtenção do benefício previdenciário de auxílio-doença é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser segurado da Previdência Social; estar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei 8.213/91); e, cumprir carência, quando for o caso.*

*Para a aposentadoria por invalidez, é necessário: ser segurado da Previdência Social, cumprir carência, quando esta for exigida; estar incapacitado para o trabalho e ser impossível a reabilitação (art. 42, da Lei 8.213/91).*

*O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017\).](#)*

*Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, **aposentadoria por invalidez** e o pensionista inválido **estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social**, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado*

*gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) - destaquei.*

*Em relação ao procedimento de **revisão da aposentadoria por invalidez realizada em 18/09/2018**, assim dispunha o artigo 47, da Lei 8.213/91 quando da revisão:*

*Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:*

*I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:*

*a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou*

*b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;*

*II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:*

*a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade;*

*b) com redução de 50% (cinquenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses;*

*c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente.*

## **DA CAPACIDADE LABORATIVA**

*Realizada a perícia judicial com o **Dr. Wallinson Moraes Silva**, Especialista em Medicina Interna, constatou que o autor, com 38 anos de idade, última profissão exercida: professor de educação física, é portador de **Hepatite viral crônica C - CID B18.2 e Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)***

*não especificada - CID B24, contudo não identificou incapacidade laborativa em DCB e após.*

*(...)*

*Como visto, o perito deixou claro a ausência de incapacidade para o trabalho do autor, de forma que não há critérios médicos para atender os pedidos apresentados nesta ação.*

*Com efeito, a discordância da parte postulante com o resultado da prova pericial não merece guarida (evento 20).*

*Registro que o fato de o perito judicial informar que o autor possui uma redução funcional de 15% em sua capacidade laboral, em face das doenças de que é portador atualmente, não é suficiente para gerar eventual direito ao recebimento de benefício por incapacidade pleiteados, pois **toda doença gera uma redução global na capacidade laborativa**, certo que o caso concreto evidencia que o autor é pessoa jovem (conta com 38 anos de idade) e atualmente as doenças encontram-se controladas, com **bom padrão respiratório, sem sinais de insuficiência respiratória, com boa compleição física, com força muscular e mobilidade articular preservadas universalmente.***

*Portanto, tenho que é desnecessária a complementação do laudo requerida, pois o perito judicial é profissional de confiança deste Juízo e avaliou a situação do autor em todo seu contexto, mormente no que diz respeito às atividades por desenvolvidas e as doenças de que é portador (**Hepatite viral crônica C - CID B18.2 e Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada - CID B24**), tendo exarado conclusão clara e enfática no **sentido da capacidade laborativa**, não sendo necessária a correção de omissão ou de inexatidão no laudo pericial, motivo pelo qual **indefiro os quesitos complementares formulados.***

*Acrescento que conforme se observa no CNIS e informações constantes nos laudos administrativos, o autor possui dois vínculos empregatícios em aberto - sequências 10 e 12 do CNIS1, evento 15. Portanto, **há clara possibilidade de o autor voltar a exercer tais vínculos empregatícios.***

*Assim sendo, não encontrada condição clínica que impeça a parte autora de voltar a realizar suas atividades habituais de trabalho, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.*

*Assinalo que a condição de portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) não determina, por si só, a existência de incapacidade*

*à míngua de infecção oportunista, comorbidade ou qualquer outra concausa deflagradora de incapacidade profissional.*

*Colaciono, a propósito, pertinente excerto do voto do Relator José Antonio Savaris, proferido no julgamento de recurso apresentado nos autos nº 200970510075271/PR (1ª Turma Recursal do PR):*

*(...)*

*Ademais, penso que a condição de portador do vírus HIV não é, por si só, condição habilitadora de outorga de benefício previdenciário por incapacidade. Se o conjunto probatório aponta para a capacidade laboral do segurado, não deve ser concedido benefício por incapacidade exclusivamente a partir do estigma a que seria submetido o segurado no exercício de sua atividade habitual.*

*A recorrente pretende o reconhecimento da incapacidade a partir de uma perspectiva exclusivamente social, mas o estigma a que se submetem os portadores de HIV não é causa para concessão do benefício por incapacidade quando o laudo médico é enfático em concluir pela capacidade laboral do segurado. O fato de ser soropositivo e assintomático em nada afeta a sua vida profissional.*

*Dessa forma, a só condição de pessoa com vírus de HIV não enseja o reconhecimento da incapacidade para o trabalho.*

*(...)*

*Na mesma linha, a Turma Regional de Uniformização considera que o fato do Recorrente ser soro positivo, por si só, não autoriza a concessão do benefício, Nesse sentido, veja-se:*

*“PREVIDENCIARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PORTADOR DO VÍRUS HIV. O puro diagnóstico de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS/SIDA é insuficiente para demonstrar a existência de incapacidade para o trabalho justificadora do deferimento do benefício previdenciário respectivo. É a incapacidade que gera o direito ao benefício e não apenas a existência da doença ou a necessidade de tratamento médico. O benefício por incapacidade pode ser concedido ao segurado portador do vírus HIV, ainda que não esteja presente a incapacidade, se o laudo atestar que peculiaridades do caso concreto, como a evidência física da doença ou fatores pessoais, impossibilitem, na prática, o retorno ou a manutenção do segurado no mercado de trabalho.” (IUJEF 2008.72.55.000797-5, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, D.E. 05/05/2009)*



*“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AIDS. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA INCAPACIDADE. 1. O requisito de "incapacidade para a vida independente", previsto na Lei nº 8.742/93, consoante entendimento da Súmula nº 29 da TNU, entende-se como a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento. 2. Em relação às pessoas com diagnóstico de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o fato de o portador do vírus **HIV poder eventualmente vir a sofrer discriminação social, por si só, não dá direito ao recebimento de benefício por incapacidade.** 3. Uma vez demonstrada a incapacidade para o trabalho, independentemente de sua 3 origem, a situação de deficiência se apresenta, de modo a conferir direito ao benefício assistencial, presentes os demais requisitos, conferindo-se a cobertura assistencial, sem qualquer investigação sobre capacidade laboral anterior que obrigasse o interessado a ter cobertura previdenciária. 4. Incidente provido. (IUJEF 2007.72.95.009113-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luísa Hickel Gamba, D.E. 08/05/2009)”*

*Transcrevo, no ensejo, os seguintes julgados do TRF da 3ª Região:*

*PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526, § ÚNICO, DO CPC. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS NÃO COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. - Preliminar de inadmissão do agravo por descumprimento do artigo 526, do § único, do Código de Processo Civil rejeitada. Comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo a quo efetuada no prazo legal. Inocorrência de cerceamento de defesa. - A dependência econômica das autoras, companheira e filha do falecido, é presumida, porque decorrente de lei (§ 4º do artigo 16 da Lei nº 8.213/91). - Qualidade de segurado do de cujus não comprovada. O último vínculo empregatício do falecido se deu no período de 24.02.2003 a 22.03.2003, mantendo a qualidade de segurado até 04.2004. O falecimento ocorreu em 16.02.2005. - O de cujus, por ocasião do último vínculo empregatício, não possuía 120 contribuições, e não há comprovação de registro de situação de desemprego junto ao órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, artigo 15, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, que somariam mais 12 meses na manutenção da qualidade de segurado. - O fato de ser portador do vírus HIV, que pode desenvolver a AIDS, nem sempre produz incapacidade física. Ausência de documentação comprobatória da alegada incapacidade. Sem requerimento administrativo para concessão de auxílio-doença. -*

*Agravo de instrumento a que se rejeita a matéria preliminar e, no mérito, nega provimento.*

*(AI 200703000293640, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, DJF3 CJ2 DATA:07/07/2009 PÁGINA: 504.) G. N.*

*PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PORTADOR DE AIDS ASSINTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 1. O agravo previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder na decisão questionada, sendo que os seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria. 3. Ainda que portadora do vírus HIV, a autora não apresenta alterações clínicas ou laboratoriais que impliquem na redução da sua capacidade laborativa. 4. Agravo legal desprovido.*

*(AC 201003990211815, DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAILA, TRF3 - NONA TURMA, DJF3 CJI DATA:08/04/2011 PÁGINA: 1782.) G. N.*

*Logo, a petição do evento 20 merece indeferimento e os pedidos devem ser julgados improcedentes, mantendo-se a cessação da aposentadoria por invalidez em face da revisão administrativa em 18/09/2018.*

### **DISPOSITIVO**

***Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação.***

*Sem custas e sem honorários nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Mantenho os benefícios da assistência judiciária gratuita já deferida.*

*Caso haja recurso de qualquer das partes dentro do prazo de 10 (dez) dias, intinem-se os recorridos para, querendo, oferecerem resposta escrita no mesmo prazo, nos termos do §2º, do art. 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c o art. 1.º da Lei n.º 10.259/01. Após, apresentadas ou não as respostas escritas, remetam-se à Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná.*

*Oportunamente, arquivem-se os autos.*

*Registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.*

Na sentença em embargos de declaração, constou:

*A parte autora opõe os presentes embargos de declaração pretendendo que seja reformada a sentença anteriormente proferida.*

*Conheço dos embargos, pois tempestivos.*

*Contudo, no mérito, não assiste razão à embargante.*

*Em suas razões, a autora sustenta que, no caso, haveria incidência da Lei n. 13.847/19 que dispensa os portadores de HIV, aposentados por invalidez, a serem submetidos a uma reavaliação pericial.*

*Referida lei alterou a redação do art. 43, § 5º, da Lei n. 8.213/91, que passou a ser a seguinte:*

*(...)*

*§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo.*

*Em que pese os fundamentos apresentados pela autora (evento 34), o autor aposentado por invalidez foi convocado pelo INSS em 2018 e, em exame pericial administrativo realizado em 18/09/2018, foi considerado capaz para o trabalho e o benefício de aposentadoria por invalidez foi cessado nesta mesma data.*

*A disposição legal invocada pela parte autora somente veio a lume em 19/06/2019, com publicação do DOU em 21/06/2019 - em Edição Extra (Lei n. 13.847/19). Logo, não houve ilegalidade do INSS ao convocar o autor para realização de nova perícia judicial, pois se trata de regra procedimental e com base na teoria do isolamento dos atos processuais, a lei nova é aplicada aos atos pendentes, tão logo entre em vigor, respeitados os atos já praticados e seus efeitos.*

*Com isso, tendo como norte que a Autarquia Previdenciária deve pautar-se pela legalidade e não houve desrespeito à lei vigente na ocasião da reconvocação da segurada para nova pericial, revela-se regular sua atuação.*

*De outro lado, a prova pericial produzida em juízo também foi concludente pela não comprovação de manutenção de quadro*



*incapacitante, conforme já devidamente analisado na sentença embargada.*

*O decisum, portanto, não padece de qualquer vício que requeira sua correção pela via recursal eleita (omissão, contradição ou obscuridade). O inconformismo com o resultado da sentença deve ser manejado por via recursal própria.*

*Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, haja vista a sua tempestividade e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação supra.*

*Intimem-se. Caso haja recurso, intimem-se os recorridos para, querendo, oferecerem resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do § 2º do artigo 42 da lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01. Após, apresentadas ou não as defesas escritas, remetam-se os autos à Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná.*

*Oportunamente, nada sendo requerido, sejam feitas as anotações necessárias e remetam-se os autos ao arquivo.*

Por sua vez, o acórdão paradigma assim decidiu:

Autos 5017172-65.2018.4.02.5101/RJ

*PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORA POR INVALIDEZ. PARTE AUTORA PORTADORA DE HIV DESDE 1998. BENEFÍCIO SERÁ CESSADO EM OUTUBRO, NOS TERMOS DO ART. 47 DA LEI 8213/91. PERITO CONSTATOU CAPACIDADE LABORATIVA. ALTERAÇÃO RECENTE NA LEI Nº 8.213/91 (5º DO ART. 43) PELA LEI Nº 13.847/19. APLICAÇÃO A TODOS OS SEGURADOS PORTADORES DE HIV CUJOS BENEFÍCIOS ESTEJAM SOB A DISCIPLINA DAS REGRAS DO ART. 47 DA LEI Nº 8.213/91. GARANTIA CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.*

*Trata-se de recurso interposto pela parte autora (evento 41) em face da sentença (evento 33) que julgou improcedentes os seguintes pedidos iniciais:*

*C - Citação do Réu para que, querendo, apresente contestação, sob pena de confissão e revelia, para, ao final, julgar procedente o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos desta inicial, com o pagamento dos atrasados desde a data da cessação, ou seja,*

*26/04/2018, até o efetivo restabelecimento, com juros e correção monetária, tornando definitiva a tutela da Evidência;*

*Em razões recursais (evento 41), aduz a parte autora que os laudos e exames dos médicos que o acompanham são claros em sua incapacidade laborativa, tendo o laudo pericial ido de encontro à realidade do portador de HIV.*

*Defende ser difícil o retorno ao mercado de trabalho na atividade de atendente de lanchonete, pois além do desgaste, há preconceito. Aduz que a doença tem quadro irreversível, além das sujeições às doenças oportunistas.*

*Aduz que deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Fala acerca do Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional.*

*Ao final, requer seja a sentença reformada para julgar procedente o pedido. Contrarrazões (evento 47).*

*A parte autora peticionou (evento 51), aduzindo que foi aprovado o projeto de Lei nº 10.159/2018, alterando a Lei para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com HIV aposentada por invalidez*

*É o relatório.*

*Passo a decidir.*

*A parte autora, que tem 43 anos de idade (Evento 1, RG3, Página 1), recebe aposentadoria por invalidez, DIB em 31/01/2012 (Evento 3, INFBEN1, Página 1), com indicação de cessação em 26/10/2019, após ter sido submetida à perícia médica em 26/4/2018, conforme art. 47 da Lei nº 8.213/91 (Evento 10, LAUDO3, Página 12).*

*A profissão declarada no laudo técnico pericial judicial foi de Atendente de Lanchonete (Evento 22, LAUDO1, Página 2).*

*Esse benefício, atualmente, está sendo regido pelo art. 47 da Lei nº 8.213/91.*

*Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:*

*I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:*

*a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou*

*b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;*

*II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade*

*a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade;*

*b) com redução de 50% (cinquenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses;*

*c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente O último exame SABI, de 26/4/2018 (após, portanto, do vencimento do prazo quinquenal previsto no inciso I do art. 47), não constatou incapacidade para todo e qualquer trabalho (Evento 10, LAUDO3, Página 12);*

*"CID: B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada*

*História: Bild Aposentado devido HIV*

*Periciando de 42 anos, relata que sua função era atendente de lanchonete. Lma cid B24 desde 1998, já fez uso de múltiplos esquemas antiretrovirais, no momento com esquema de regaste, histórico de pneumonia jul/2017 e infecção urinária dez/17, com queixa atual de cefaleia crônica e insônia, aguarda parecer do neurologista e psiquiatria. ass dr Luiza Carneiro crm 5283077-1 Exame laboratorial 02/2018 HIV não detectável e CD4 488/mm3 dentro do normal aguarda cirurgia plastica deformidade abdome, , propria médica assistente declara que não há contra indicação para cirurgia plastica pois encontra-se boa resposta virológica CD8 1055 cel e CV < 40 e CD4 494 em histórico de ultima perícia em 2012 consta cv 7.993 cd4 96cel portanto hoje demonstrando melhora imunológica Considerações: Periciando de 42 anos, atendente de lanchonete, com último laudo médico declarando que encontra-se*

*boa resposta virológica CD81055 cel e CV < 40 e CD4 494, sem sinais de infecção secundária, portanto sem elementos técnicos para parecer favorável conf dec 3048/99 art 71"*

*Pois bem, depreende-se que para o segurado fazer jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, assim dispõe o artigo 42 da Lei 8.213/91:*

*“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (grifos nossos)*

*Assim, devem restar comprovadas a incapacidade laborativa atestada em laudo pericial, a qualidade de segurado e a carência exigida para a implementação dos benefícios em análise.*

*Nos presentes autos discute-se a questão da incapacidade para todo e qualquer trabalho, não havendo controvérsia sobre a qualidade de segurado da parte autora, bem como sobre a carência para obtenção do benefício. Antes de tudo, porém, cabe observar que é fato incontroverso nos autos que a parte autora da ação é portadora do vírus da imunodeficiência adquirida-HIV.*

*Pois bem, recentemente o legislador alterou a Lei nº 8.213/91 acrescentando a seguinte regra ao art. 43:*

*§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo.*

*Eis a redação do §4º do mesmo dispositivo legal:*

*§4o O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.*

*Ora, não há como desconsiderar esse nova disposição legal, tendo em vista que a aposentadoria é direito fundamental (art. 7º XXIV, da Constituição da República). Se esse direito vem regulamentado em regra legal que deixa de exigir determinado requisito em função da condição de saúde do segurado, isto é, mesmo capaz de trabalhar assegura-se o direito ao benefício aos portadores do vírus HIV, não há que impedir que aqueles segurados que já se encontravam nessa situação antes do advento da nova lei possam valer-se dela para que*

*seus benefícios sejam restabelecidos, como ocorre no caso concreto, sob o risco de se ferir a isonomia.*

*Extinguir o processo sem julgamento do mérito seria só prejudicial à parte, que teria que retornar ao INSS para fazer valer um direito que já está previsto em regra jurídica, à qual se ajusta pelas provas produzidas no processo judicial e que, face aos princípios que regem os Juizados Especiais, pode tranquilamente ser exercido, sem falar, como já dito, na garantia constitucional ao benefício previdenciário como direito fundamental.*

*Por essas razões, há, portanto, que se reformar a sentença.*

*Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS em obrigação de não fazer, qual seja, não submeter a parte autora ao escalonamento previsto no art. 47 da Lei nº 8.213/91; em obrigação de fazer, de retirar a data de cessação do benefício NB 6017666359 (Evento 3, INFBEN1, Página 1); e em obrigação de pagar as diferenças decorrentes da aplicação do escalonamento previsto nas letras "a", "b" e "c" do inciso II do art. 47 da Lei nº 8.213/91, corrigidas pelo INPC, com juros de mora idênticos aos da caderneta de poupança, aplicados a partir da citação do réu. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Passados os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem.*

Os demais acórdãos do Rio de Janeiro, citados como paradigma, refletem posicionamento idêntico ao citado.

O acórdão da Turma Recursal de Santa Catarina não serve como paradigma válido, uma vez que não cabe pedido de uniformização nacional fundado em divergência entre turmas da mesma região.

Num primeiro aspecto, constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido.

Por seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

Do exame comparativo, chega-se à ilação de que não se trata de hipótese que implica reanálise de matéria fática, mas tão-somente em se determinar se é possível, ou não, retroagir para momento anterior à edição da Lei 13.847/19, a regra contida no art. 43, § 5º da Lei 8.213/91, para os benefícios que foram revisados nos termos do art. 43, § 4º da Lei 8.213/91.

**O incidente de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade**, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

No entanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **saber se a dispensa de avaliação a que se refere o art. 43 § 5º da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.847/19, aplica-se também aos benefícios que foram revisados antes de sua edição**.

Ante o exposto, voto por CONHECER E, NA PARTE CONHECIDA, INDICAR O TEMA PARA SER JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA NA TNU.

**ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS**

**Juiz Relator**



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003  
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº  
5017999-45.2018.4.04.7001/PR**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

**REQUERENTE:** EDGAR ALBANO JUNIOR

**REQUERIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**EMENTA**

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE RETROAGIR A REGRA CONTIDA NO ART. 43 § 5º DA LEI 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.847/19, PARA OS BENEFÍCIOS QUE FORAM REVISADOS ANTES DE SUA EDIÇÃO.

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E, NA PARTE CONHECIDA, INDICAR O TEMA PARA SER JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA NA TNU, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se a dispensa de avaliação a que se refere o art. 43, § 5º da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.847/19, aplica-se também aos benefícios que foram revisados antes de sua edição".

Brasília, 19 de junho de 2020.

**ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS**

**Juiz Relator**